**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) ***

# طلب علاج أول مرة / متردد

**إسم المريض رباعياً :** زينب عبد التواب ميزار عبد المجيد
**المحافظة :** القاهره **الحي / المدينة :** باب الشعريه **العنوان :** =
**رقم البطاقة :** 27308230100701 **رقم التليفون :** 01148979278 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 23-08-1973 **المهنة :** ربه منزل

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي** **المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------) **التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**خطة العلاج :** أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

**Name:** زينب عبد التواب ميزار عبد المجيد
**National ID:** 27308230100701

## تقرير طبي

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | |
|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | **بشأن تقرير طبي للمريض** |
| **بقسم:** | **رقم طبي:** |

**نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | |
|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** -- --:-- yyyy-mm-dd | **تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026 |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة**

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis**

| | |
|---|---|
| **التاريخ :** **05-07-2026** | **الوقت :** **-- --:--** |
| | **الطبيب المعالج :** د/شيماء لاشين |




DMS
زومیت




National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستافروسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي صحة مصر

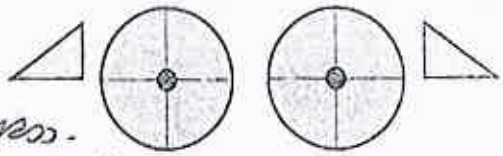
# MDT FORM 25/11/2025 G

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | أمل خيري محمد | MRN | 3062/2025 |
| | | ID | 01151604196 |
| Age | 52 yo | Phone | 01148854234 |
| Menopausal status | Post. | Marital status | W. |
| NRS SCORE | | Family history | -ve. |
| BMI | | REASON OF MDT | New case. |
| CO morbidity | free. | | CVC1-12-10-2024 |

## Clinical Data

BX: IDC GII

R PS1 L



| ER: | PR: | HER 2: | Ki67: |
|---|---|---|---|
| 0/8 | 0/8 | 3+ | 38% |

Sonomammography: UIQ Part. third. irregular speculated high density mass. Distortion. 5mm deep to skin/ hypoechoic.

Mets Workup: Solid mass. Zoneb & Zone C. TNM 2 0 0
2.5x2cm & 1.6x1.2cm.
enlarged axillary L.N - preserved hilum.
CT CAP free. Bone Scan → free.

Recommendations: for NACT then ابتدائي BCS
ثم SLNB

MDT OUTCOME & PLAN (1) Clips insert
(2) start TC HP x6 cycles.
then BCS & SLNB

| SIGNATURE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICAL ONCOLOGY | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
| د/ أمل عبد الله | | | | | |

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

| | |
|---|---|
| **Name:** زينب عبدالتواب ميزار عبدالمجيد | |
| **MR. :** 5610 | |

Detailed Medical Report

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | | **بشأن تقرير طبي للمريض** | |
| **بقسم:** | | **رقم طبي:** | |

**ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** | | **تاريخ وساعة الخروج :** | |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه**

**The patient was diagnosed with primary right-sided breast carcinoma, clinical stage T3 N1, invasive ductal carcinoma, grade 2. Hormone-receptor testing showed estrogen receptor positivity (7/8) and progesterone receptor positivity (8/8), HER2 negative, and a Ki-67 proliferation index of 25%. The disease was classified as recurrent, with three cycles of adjuvant chemotherapy followed by three cycles of adjuvant radiotherapy. Follow-up imaging performed on 23 May 2022 included a right mammogram, which demonstrated post-treatment changes without evidence of residual disease (ypT2, ypN0/3). The patient remains disease-free as of the latest assessment and is eligible for bone-protective therapy with zoledronic acid (Zometa) and endocrine therapy with anastrozole (Arimidex). The current plan is continued surveillance and initiation of the indicated supportive treatments.**

**تحريرا في ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **التاريخ :** | 19-09-2026 | **الوقت :** | |

**الطبيب المعالج :** dina makram

**يعتمد ,**

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patient Name | : الأستاذه / امل فايز محمد سليم | Request No. | : 13005133 |
| Patient No. | : 27210130102448 | Request Date | : 09/10/2025 |
| Path No. | : 3089/25 | Verification Date | : 16/10/2025 |
| Sex | : Female | Financial Category | : جوستاف روسي - مباشره |
| Age | : 52 Y | Department | : Out Patient |
| Referreing Doc : | | Registered by | : Mrs.Mayada Hegazy |

## Pathology Report

Clinical Data: Left breast UIQ mass in patient with positive family history (matternal side aunt).
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 08/10/2025.

Gross Examination:
- Four grey white tissue cores, ranging in size from 0.8 cm up to 1.2 cm long. Totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
* DCIS: Absent.
* Angioinvasion: Absent.
* Perineural invasion: Absent.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 30%.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed



غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

| | |
|---|---|
| Date : 01/10/2025 | Patient Name: Amal Fayez Mohamed Selim |
| Age : 53 Year(s) | Exam : MAMMOGRAPHY BOTH |
| Pat. ID: 121842 | Medical ID: 10984 |

**Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:**

**Clinical summary:** 45 years old female with positive family history (maternal side aunt), complaining of left breast lump of a month duration.

**Findings:**

**Right breast.**

- Heterogenously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated heterogeneous breast parenchyma with mottled appearance yet no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

**Left breast.**

- Heterogenously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- UIQ posterior third , irregular speculated high density mass lesion with distortion yet no suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated heterogeneous breast parenchyma with mottled appearance.
- 10 o'clock, zone b , 5 mm deep to the skin, irregular spiculated heterogenous hypoechoic solid mass lesion with surrounding echogenic halo, posterior acoustic shadowing and mild internal vascularity on color Doppler study as well echogenic foci measuring 25 x 20 mm.
- 12 o'clock zone c irregular mas lesion measures 16 x 12 mm , with Heterogeneous parenchyma in between
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Enlarged axillary lymph nodes , with preserved hilum , cortical thickness 2.5 mm

***nclusion:-***

- ***Right breast (BIRADS 2): NORMAL STUDY .***
- ***Left breast (BIRADS 5): UIQ multifocal malignant process .***

***Recommendation:-***

- ***For biopsy and histopathological correlation.***

Best Regards,
*DR. RANIA AHMED , MD*
Signature Dr. Amal Hegazy
01/10/2025 3:56 PM

for readjustment then CBS.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

| | |
|---|---|
| Patient Name: Amal Fayez Mohamed Selim | Date : 01/11/2025 |
| Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis) | Age : 53 Year(s) |
| Medical ID: 3062/2025 | Pat. ID: 121842 |

## NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

**A known case of left breast cancer

**I Chest: -**

- Left breast mass uIQ measures 2.7 x 3.7 cm .
- Right supraclavicular lymph node 17 x7 mm.
- Multiple enlarged left axillary lymph nodes , the largest measures 7 x13 mm
- No hilar or mediastinal lymph node .
- Nosiazable pulmonary nodules or masses.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Enlarged heterogenous right thyroid lobe .

**II Abdomen & pelvis:**

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Cholecystectomy clips are noted .
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Diverticular disease of sigmoid and descending colon.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***III The scanned skeleton:***

- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.
- Right femoral sclerotic lesion likely bone island.

**Opinion:**

- ***No pulmonary ,hepatic or bony metastatic deposits***

*Dr. Reham Khedr, MD*
Signature Reeham.Khader
03/11/2025 5:19 PM



CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

NILE
SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Amal Faiz Mohammed Selim
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : No doctor

Date : 05-11-2025 11:14
Medical No. : 242031
Ins.Company : تعاقد مستشفيات

NILE DIAGNOSTIC CENTER

# Tc$^{99}$m MDPSKELETAL SCINTIGRAPHY

## History

- A 52-year-old patient, with history of breast cancer and referred for metastatic workup..

## Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

## Findings

- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are noted at the spine and big joints.

## Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine



Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]